

Eritema Multiforme y Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)

1. Introducción y relevancia clínica

El **eritema multiforme (EM)** y el **síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** representan un **espectro de enfermedades mucocutáneas** caracterizadas por **necrosis epidérmica** secundaria a una **reacción de hipersensibilidad inmunológica**.

Aunque comparten ciertos mecanismos patogénicos, se diferencian por **su severidad y extensión**:

Entidad	Afectación cutánea	Mortalidad aproximada
Eritema multiforme menor	<10% de la superficie corporal	<1%
Eritema multiforme mayor (SSJ)	10–30% SC + mucosas	5–10%
Necrólisis epidérmica tóxica (NET o Lyell)	>30% SC + mucosas	25–35%

Relevancia clínica

- El SSJ/NET son **urgencias dermatológicas potencialmente letales**, con compromiso sistémico severo.
 - El EM, por otro lado, suele ser **autolimitado y de origen infeccioso**.
 - Reconocer precozmente estas entidades es esencial para **suspender el fármaco causal** y **prevenir complicaciones graves**.
 - En EUNACOM, es un **tema clásico de urgencias dermatológicas**, con énfasis en diagnóstico diferencial, etiología y manejo inicial.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Mecanismo inmunológico

Eritema multiforme (EM):

- Mediado por **respuesta citotóxica de linfocitos T CD8+** frente a antígenos virales (habitualmente *Herpes simplex virus*).
- Estos linfocitos destruyen queratinocitos infectados → necrosis focal epidérmica → lesiones en “diana”.

Síndrome de Stevens-Johnson / NET:

- Reacción de **hipersensibilidad tipo IVc** inducida por fármacos.
- Activación de linfocitos T CD8+ y liberación de **perforina, granzima B y granulysina**, que inducen apoptosis masiva de queratinocitos.
- Resultado: **necrosis epidérmica difusa**, desprendimiento cutáneo y daño mucoso severo.

2.2. Etiología y factores desencadenantes

Causa	Eritema multiforme	Stevens-Johnson / NET
Infecciones (90%)	<i>Herpes simplex</i> (principal), <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , EBV	Raro
Fármacos (10%)	Penicilinas, AINEs	Sulfas, anticonvulsivantes (fenitoína, carbamazepina, lamotrigina), alopurinol, antibióticos β-lactámicos
Otros	Vacunas, neoplasias, radioterapia	Neoplasias hematológicas, VIH, inmunosupresión

2.3. Factores de riesgo

- VIH / inmunosupresión.
 - Historia previa de SSJ/NET.
 - Polifarmacia.
 - Genética: HLA-B*1502 (poblaciones asiáticas, riesgo con carbamazepina).
-

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1. Eritema multiforme (EM)

Forma menor (más frecuente)

- Lesiones **en diana o blanco**: tres zonas concéntricas:
 1. Centro necrótico oscuro o vesicular.
 2. Anillo pálido edematoso.
 3. Halo eritematoso periférico.
 - Distribución **simétrica y acral**: dorso de manos, pies, codos, rodillas.
 - **Mucosas**: pueden afectarse levemente (EM mayor).
 - **Síntomas sistémicos leves**: fiebre baja, malestar.
 - Duración: 2–3 semanas, curso autolimitado.
 - **Recidivante**: en 30–40% de casos, especialmente asociado a herpes recurrente.
-

3.2. Síndrome de Stevens-Johnson / Necrólisis epidérmica tóxica

Fase prodrómica (1–3 días antes de las lesiones)

- Fiebre alta, malestar general, mialgias, odinofagia, conjuntivitis.

Fase cutánea

- Lesiones máculo-papulares eritematosas que confluyen y forman **áreas de necrosis epidérmica**.
- Desprendimiento de la epidermis con presión tangencial (**signo de Nikolsky positivo**).
- Afectación **mucosa severa**: oral, ocular, genital.
- Dolor cutáneo intenso y riesgo de deshidratación, sepsis o shock.

Extensión

- SSJ: <10% superficie corporal.
- NET: >30% SC (confluencia extensa de ampollas y áreas denudadas).
- Mixta SSJ/NET: 10–30%.

3.3. Compromiso mucoso (en ambas formas severas)

- **Oral**: erosiones dolorosas, sangrantes, estomatitis.
- **Ocular**: conjuntivitis, queratitis, úlceras corneales (puede causar ceguera).
- **Genital**: erosiones, disuria, sinequias vaginales.

3.4. Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Pénfigo vulgar	Ampollas flácidas, Nikolsky positivo, anticuerpos anti-desmogleína positivos
Síndrome de piel escaldada estafilocócica (SSSS)	En niños, sin compromiso mucoso, cultivo nasal positivo a <i>S. aureus</i>

Toxicodermia simple	Exantema sin necrosis ni mucositis
Eritema fijo medicamentoso	Lesiones redondeadas, recidivantes en el mismo sitio
Enfermedades virales exantemáticas	Lesiones maculares o papulares sin necrosis ni ampollas

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Diagnóstico clínico

El diagnóstico es **clínico**, sustentado en:

- Antecedente de **uso reciente de fármacos (últimos 8–21 días)**.
 - Lesiones **eritematosas, ampollares, con signo de Nikolsky positivo**.
 - Compromiso **mucoso y sistémico** (dolor, fiebre, deshidratación).
-

4.2. Exámenes complementarios

Examen	Utilidad
Biopsia cutánea	Confirmación histológica (necrosis queratinocítica extensa, desprendimiento epidérmico subepidérmico)
Hemograma	Leucocitosis o linfopenia
PCR y VSG	Marcadores de inflamación

Electrolitos, función renal y hepática	Evaluar deshidratación y toxicidad
Cultivos (sangre, piel, orina)	Si hay sospecha de infección secundaria
Serología herpes o Mycoplasma	Si EM sospechoso de causa infecciosa

4.3. Escala pronóstica SCORTEN (para SSJ/NET)

Variable	Puntos si presente
Edad >40 años	1
Cáncer / neoplasia	1
Desprendimiento >10% SC en 24 h	1
FC >120/min	1
BUN >10 mmol/L	1
Glucosa >14 mmol/L	1
Bicarbonato <20 mmol/L	1
Mortalidad estimada: 0–1 puntos: 3% 2: 12%	

3: 35%
4 o más: >60%

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Principios generales

- Suspensión inmediata del fármaco sospechoso.
 - Atención en unidad especializada (UCI o unidad de quemados) si extensión >10% SC.
 - Manejo de soporte es **fundamental y salva vidas**.
-

5.2. Tratamiento del Eritema Multiforme (EM)

Severidad	Tratamiento
Leve (EM menor)	Sintomático: antihistamínicos, corticoides tópicos, emolientes
Asociado a herpes recurrente	Aciclovir 400 mg cada 12 h × 6 meses (profilaxis)
EM mayor (mucoso)	Corticoides sistémicos breves (prednisona 0,5 mg/kg/día × 5–7 días)
Causa infecciosa bacteriana	Tratar infección subyacente (p. ej. <i>Mycoplasma pneumoniae</i>)

5.3. Tratamiento del SSJ / NET

A. Manejo general de soporte

1. **Hospitalización inmediata** en UCI o unidad de grandes quemados.
2. **Hidratación y balance hidroelectrolítico** (líquidos IV, control de diuresis).
3. **Control térmico y ambiente estéril** (evitar infecciones nosocomiales).
4. **Analgesia adecuada y nutrición enteral o parenteral.**
5. **Antibióticos sólo si hay infección comprobada** (no profilácticos).
6. **Cuidado ocular:** derivar precozmente a oftalmología (lubricantes, antibióticos tópicos).
7. **Cuidado de mucosas:** anestésicos tópicos, higiene bucal, evitar adherencias genitales.

B. Tratamiento farmacológico específico

Terapia	Evidencia / comentarios
Corticoides sistémicos (prednisona 1 mg/kg/día o pulsos de metilprednisolona)	Controversial; pueden ser útiles si se inician precozmente (<48 h), pero aumentan riesgo infeccioso
Inmunoglobulina IV (2 g/kg en 3–5 días)	Bloquea FasL; evidencia variable, útil en casos graves o refractarios
Ciclosporina A (3–5 mg/kg/día)	Estudios recientes muestran reducción de mortalidad y reepitelización más rápida
Etanercept / infliximab (anti-TNF)	Opciones emergentes con buenos resultados en SSJ/NET tempranos
Plasmaféresis	En casos graves o con fallo multiorgánico
MINSAL Chile (2023): recomienda manejo de soporte intensivo + considerar ciclosporina o inmunoglobulina IV según disponibilidad y criterio clínico.	

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo / consecuencias
Sepsis bacteriana	Infección por <i>Staphylococcus aureus</i> o <i>Pseudomonas</i> en piel denudada
Deshidratación y alteraciones electrolíticas	Pérdida de líquidos por exudado
Insuficiencia renal aguda	Necrosis tubular por sepsis o hipovolemia
Compromiso ocular	Queratitis, sinequias, ceguera parcial
Estenosis esofágica o genital	Cicatrización mucosa
Recurrencias	5–10%, sobre todo en EM asociado a herpes

Pronóstico:

- EM: excelente (autolimitado).
- SSJ: mortalidad 5–10%.
- NET: mortalidad 25–35%, según SCORTEN y comorbilidades.
- La reepitelización cutánea ocurre en 2–3 semanas, pero las secuelas pueden ser permanentes (oculares, cicatriciales o pigmentarias).

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. **Eritema multiforme → infecciones (Herpes simplex).**
Stevens-Johnson / Lyell → fármacos.
 2. **Lesiones en diana (“target”) → eritema multiforme.**
Ampollas + signo de Nikolsky positivo → SSJ/NET.
 3. **Compromiso mucoso severo** distingue SSJ/NET del EM.
 4. **Suspender inmediatamente el fármaco sospechoso** salva vidas.
 5. En EM recurrente por herpes, usar **aciclovir profiláctico**.
 6. **Ciclosporina o inmunoglobulina IV** pueden reducir mortalidad en SSJ/NET.
 7. En EUNACOM, la pregunta típica describe un paciente con **fiebre, lesiones ampollares, mucositis y uso reciente de un fármaco.**
-



Errores comunes

- Confundir EM con SSJ (en SSJ hay necrosis y compromiso sistémico).
 - No suspender todos los medicamentos recientes.
 - Iniciar antibióticos profilácticos sin infección comprobada.
 - No manejar en unidad especializada.
 - No derivar a oftalmología (riesgo de ceguera).
 - Usar corticoides tardíamente o sin soporte adecuado.
 - Ignorar la necesidad de seguimiento a largo plazo por secuelas oculares o mucosas.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **eritema multiforme (EM)** es una reacción autolimitada, generalmente **por virus herpes simplex**, con **lesiones en diana acrales**.
2. El **síndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** y la **necrólisis epidérmica tóxica (NET)** son **reacciones medicamentosas graves** con necrosis epidérmica.
3. El **signo de Nikolsky positivo** y el **compromiso mucoso severo** son diagnósticos de SSJ/NET.
4. La **suspensión inmediata del fármaco causal** es la medida más importante.
5. El **manejo debe realizarse en unidad de quemados o UCI**, con enfoque de soporte vital.
6. **Ciclosporina o inmunoglobulina IV** pueden ser terapias adyuvantes útiles.
7. En EUNACOM, la clave está en **identificar una reacción medicamentosa con ampollas, necrosis y mucositis**.